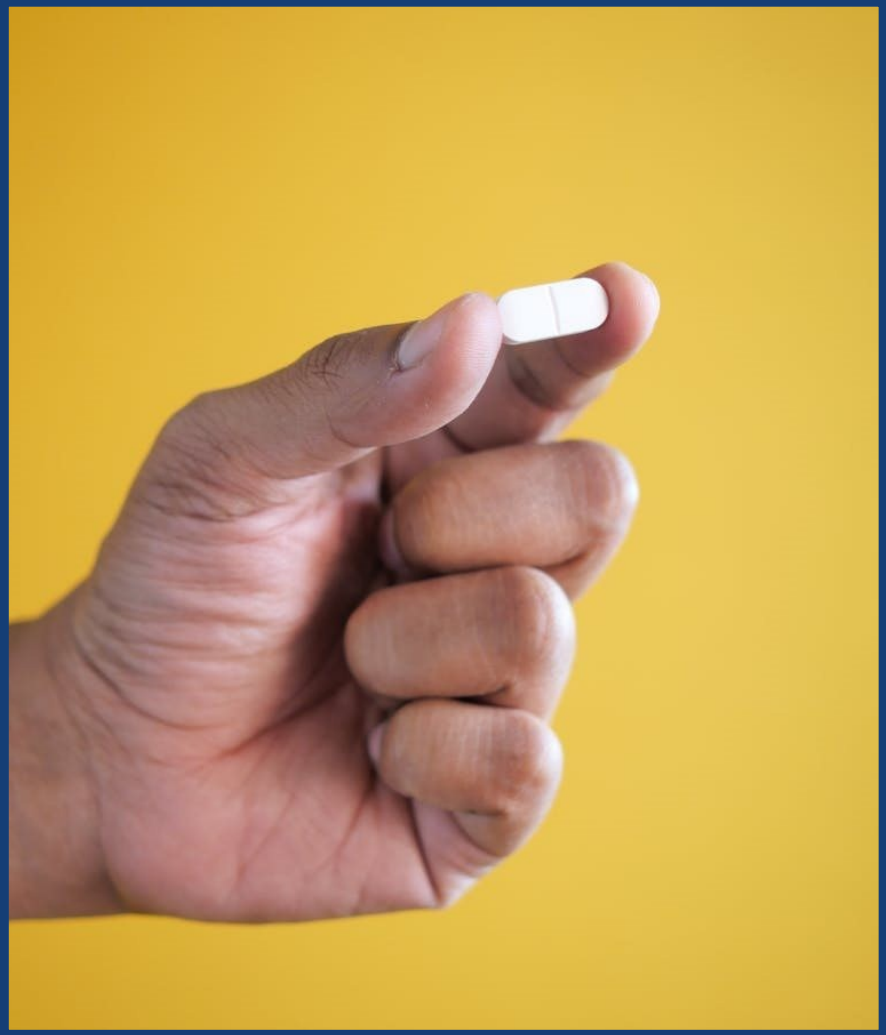
校园用药生存课

合理用药

给宿舍药箱上堂课

会选药 · 看成分 · 避误区

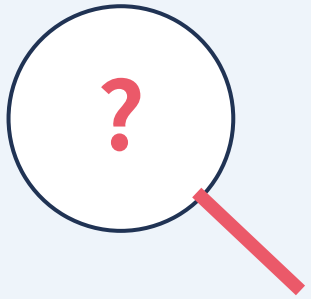


苏州大学｜选修课课堂展示
主讲：同学甲 / 同学乙

35 分钟 · 2 位讲者 · 4 部分

今天的路线：从会判断，到会行动

01



基本原则

5 分钟

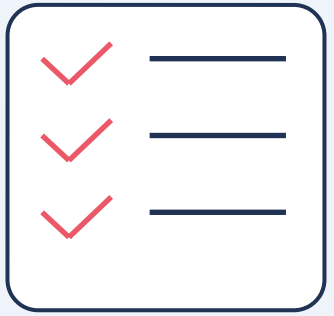
02



宿舍误区

17 分钟

03



安全用药

8 分钟

04



选择挑战

5 分钟

全程约 35 分钟，已包含举手互动。

室友感冒了，你先做哪一步？

单选

A 用上次的剩药，沿用当时吃法

B 拍清楚药盒，先核对再作决定

C 按最主要症状，先挑一盒试试



举手选择 A / B / C ｜暂不揭晓

合理用药，要同时过四关

01 安全

关注禁忌与不良反应

02 有效

针对真正需要解决的问题

03 经济

避免不必要的花费

04 适宜

适合这个人、这个时机

刚才选 B：先了解，再决定。

两盒药，是“双保险”还是撞车？



头痛还在，要不再加一盒？



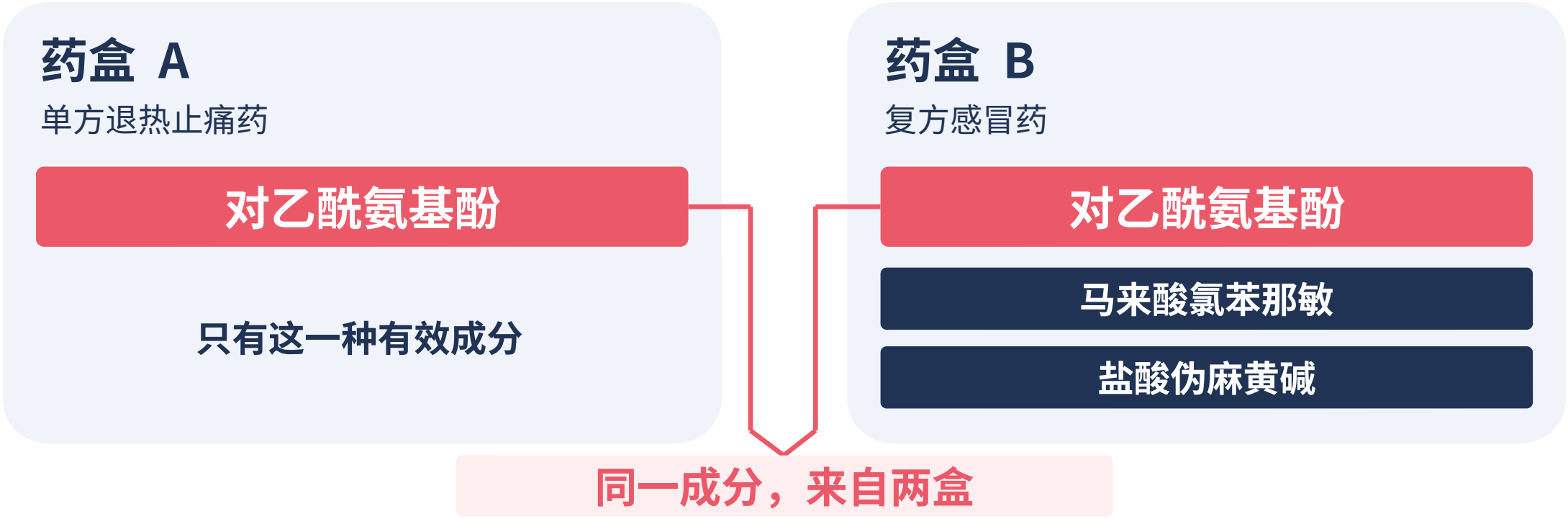
名字不同，应该不重复吧？



药盒不同，里面的成分呢？

包装不同，也可能含有同一成分。

药盒不同，成分可能“撞车”



① 圈出重复 → ② 核规格与已服情况 → ③ 未确认，不自行叠加

同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

18:00

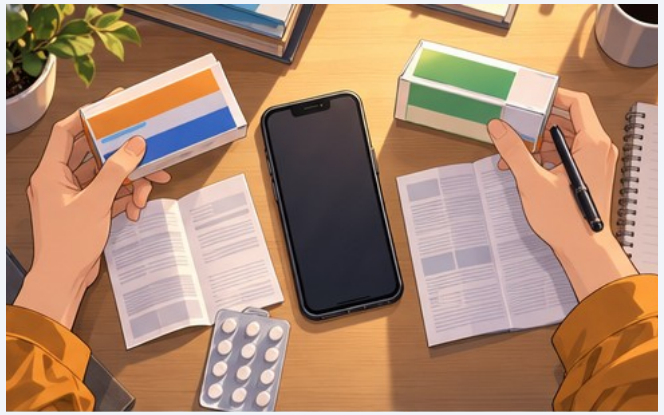


已经服过一种复方感冒药

20:00



症状还在，准备加一盒退热药



成分、规格、已服用量还没核对

成分、规格、今天吃过什么：先核清，再决定。

室友群的三条消息，你给哪条点赞?

A 拍下两盒成分，圈出相同的名字

B 按症状拆开安排，把服药时间错开

C 补上今天已服药名、规格与时间

可多选



可多选 A / B / C ｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息?

答案 A + C：先把两类信息凑齐

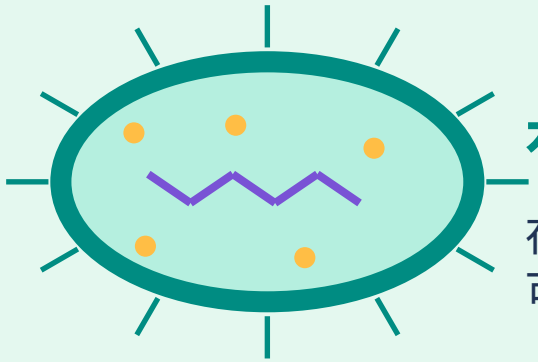
A + C

- A 圈出同名成分，发现可能重复
- C 补规格和已服记录，核对累计使用
- B 错开时间，仍不能代替完整核对

同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

细菌

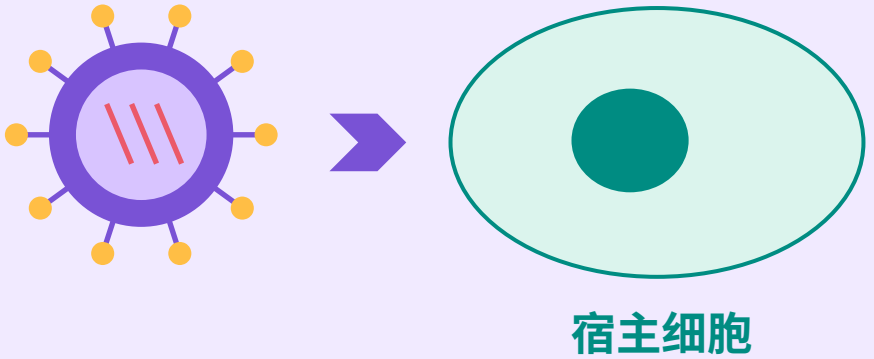


有细胞结构

在适宜条件下
可自行繁殖

某些细菌结构或过程
可成为抗生素的靶点

病毒



宿主细胞

无细胞结构
依赖宿主细胞复制

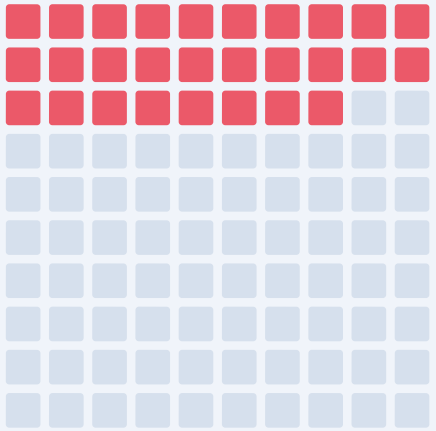
普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

美国门诊抗生素处方

至少

28%



被估计为不必要

药物副作用导致的急诊

5 次中，约 1 次

涉及抗生素反应



皮疹、腹泻，也可能严重过敏

没有治疗需要，也要承担用药风险。

把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

01



先确认需要

感冒症状，不自动等于要用抗生素

02



不接室友剩药

相似症状，不代表同一病因

03



按处方执行

疗效或反应有疑问，及时咨询

先确认需要，再按具体处方使用；有疑问及时联系医生或药师。

案例③：鼻子舒服了，上课却犯困



终于不用一直擦鼻涕！



鼻子好了，脑子想“下课”……

症状缓解，也要留意精神状态与日常活动。

同一种组胺信号，为什么有两种影响?

鼻部：参与过敏反应



阿嚏!

组胺

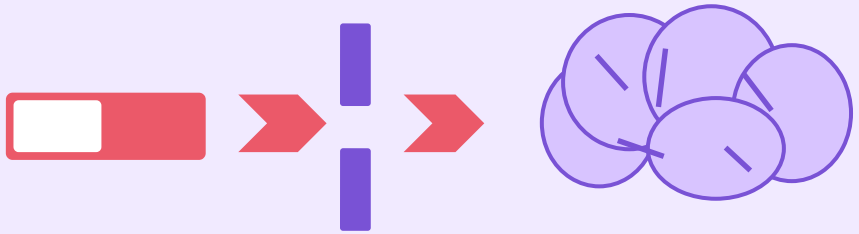
H1 受体

抗组胺药

影响受体作用 → 缓解部分症状

脑内：也参与维持清醒

血脑屏障



脑内 H1 信号

部分药物可进入脑内

清醒相关信号受影响 → 可能嗜睡

同一种信号，在鼻部和脑内承担不同作用。

聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

A 先吃点东西，把两者错开两小时

B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒

C 今晚先换白水，按具体药名查要求

单选



单选｜今天服过抗过敏药，具体饮酒要求未确认；下一页再揭晓。

案例④：聚餐这杯酒，先停一下



白天服过药，今晚聚餐怎么办?



室友：就喝一点，没事吧?



我先换白水，再核实这盒药的要求

刚才选 C：拿不准就先不喝；错开两小时、酒量好都不能代替核实。

安全用药四步：看、核、问、记

看

症状、说明书、就医信号

核

成分、剂量、间隔、禁忌

问

医生 / 药师，确认不确定处

记

药名、时间、用量与反应

刚才选 C ｜把“不确定”变成一个咨询动作。

说明书很长？先定位这六处

1. 成分 / 通用名
2. 适应证或功能主治
3. 用法用量
4. 禁忌与注意事项
5. 相互作用 / 不良反应
6. 贮藏条件 / 有效期



先找成分、用法和禁忌，把关键信息看清。

时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

01



漏服

先查具体处理要求，不自行加倍

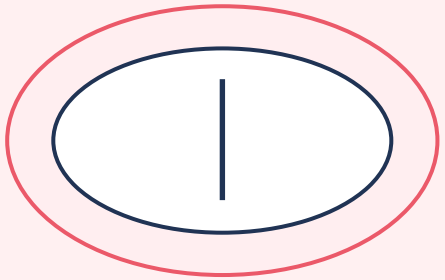
02

剂量
间隔
疗程

疗程

按处方执行，有问题及时咨询

03



剂型

缓释、肠溶等，不随意掰碎

不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

问药师时，把信息一次说清



- 我有什么症状，持续多久？
- 我正在吃什么，何时吃了多少？
- 我有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

什么时候，不该继续自己试药?

120

严重急症
立即求助

呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常

立即急救

疑似超量或误服

及时寻求医疗帮助

症状持续、加重或反复

及时就诊



严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。

宿舍药箱：留信息，也留秩序



- 原包装＋说明书｜一起保留
- 有效期＋贮藏条件｜定期检查
- 个人用药记录｜不混装、不分享处方药

数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

把四个误区，换成四个动作

01	感冒药叠加	›	核对成分
02	感冒吃抗生素	›	先确认是否需要
03	抗过敏后困倦	›	查提示、避高风险活动
04	吃药后聚餐	›	先核实饮酒要求

看、核、问、记：现在进入简单挑战。

综合挑战：小苏今晚怎么安排？



01 已服：一种复方感冒药

02 准备：再加一盒药＋参加聚餐

03 当前：成分没核对，症状尚轻

成分没核对，饮酒要求也还没确认。

小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查

B 药盒和已服记录，一起交给药师核对

C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

可多选



可多选 A / B / C ｜逐条判断；想 10 秒，再举手

答案 A + B：把建议拼成完整行动

A + B

- A 饮酒要求未明 → 先用白水，再查询
- B 药盒与已服记录 → 一起核对，再决定
- C 沿用经验错开时间 → 信息缺口仍在

若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

把判断带回生活

药可以常备，
判断不能省略。

先看说明书，再做用药决定

核对重复成分，记录已服药物

拿不准，问医生 / 药师

会看 · 会核 · 会问 · 会记



谢谢大家